

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

ÍNDICE DE CALIDAD DE SUEÑO DE PITTSBURGH (PSQI)

Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse et al., 1989) · Validación Española (Royuela & Macías, 1997; Jiménez-Genchi et al., 2008)

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL Y FICHA RESUMEN

Nombre oficial	Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh (Pittsburgh Sleep Quality Index, PSQI)
Sigla / Acrónimo	PSQI (ICSP en publicaciones hispanas)
Autoría original	Daniel J. Buysse, Charles F. Reynolds, Timothy H. Monk et al. (Univ. of Pittsburgh, 1989)
Adaptación en español	Royuela & Macías (1997, Mapfre Med); Jiménez-Genchi et al. (2008, Salud Ment México)
Constructo evaluado	Calidad global subjetiva del sueño y patrones de perturbación a lo largo del último mes
Población diana	Adultos y ancianos en contextos clínicos psiquiátricos, médicos, quirúrgicos y comunitarios
Tiempo de aplicación	5 a 10 minutos (autoinforme estructurado con preguntas abiertas y cerradas)
Estructura y formato	19 ítems autoinformados agrupados en 7 componentes (más 5 ítems complementarios de cama)
Condiciones de uso	Uso libre en investigación y práctica clínica no comercial; propiedad intelectual de Univ. of Pittsburgh

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La calidad del sueño es un constructo multidimensional complejo que abarca dimensiones cuantitativas objetivas (latencia, duración, número de despertares y eficiencia) y dimensiones cualitativas subjetivas (profundidad percibida, descanso reparador, impacto somático y estabilidad del estado anímico diurno). El PSQI fue creado para llenar el vacío existente entre los estudios de laboratorio de polisomnografía (costosos y poco ecológicos) y las simples preguntas exploratorias clínicas.

El marco teórico del PSQI asume que las perturbaciones del sueño en el último mes reflejan un fenotipo integral donde interactúan factores biológicos, comportamentales y psicológicos. Su diseño permite obtener una puntuación global resumida de fácil manejo clínico y, al mismo tiempo, desagregar el perfil del paciente en siete dimensiones funcionales específicas para dirigir intervenciones farmacológicas o psicoterapéuticas concretas.

3. COMPOSICIÓN DE LOS 7 COMPONENTES CLÍNICOS DEL PSQI

Componente	Ítems Origen	Rango	Contenido y Definición Operativa
C1: Calidad Subjetiva	Ítem 6	0 - 3	Autovaloración global del descanso (Excelente a Muy mala)
C2: Latencia de Sueño	Ítem 2 + Ítem 5a	0 - 3	Minutos hasta conciliar y frecuencia de demora > 30 min
C3: Duración del Sueño	Ítem 4	0 - 3	Horas reales dormidas (> 7 h = 0, 6 – 7 h = 1, 5 – 6 h = 2, < 5 h = 3)
C4: Eficiencia Habitual	Ítems 1, 3, 4	0 - 3	Razón horas dormidas / horas en cama (> 85% = 0; < 65% = 3)
C5: Perturbaciones	Ítems 5b a 5j	0 - 3	Despertares, nicturia, tos/ronquidos, frío, calor, pesadillas, dolor
C6: Uso de Hipnóticos	Ítem 7	0 - 3	Frecuencia de consumo de medicación para dormir (recetada o libre)
C7: Disfunción Diurna	Ítems 8 y 9	0 - 3	Somnolencia diurna en tareas y pérdida de entusiasmo/ánimo

EVALUACIÓN PSICOMÉTRICA, BAREMACIÓN Y CÓMPUTO CLÍNICO

4. PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS EN POBLACIÓN ESPAÑOLA Y LATINOAMERICANA

Consistencia interna	Adecuada fiabilidad global; alfa de Cronbach $\alpha = 0.81$ en la validación española de Royuela y Macías (1997) y $\alpha = 0.78$ en pacientes psiquiátricos (Jiménez-Genchi et al., 2008).
Estabilidad temporal	Coefficiente test-retest a 3 semanas: $r = 0.85 - 0.87$, mostrando gran estabilidad en pacientes sin cambios en el estado clínico ni farmacológico.
Validez concurrente	Correlación positiva robusta con el Índice de Severidad del Insomnio (ISI, $r = 0.77$), Hamilton Depresión (HRSD, $r = 0.62$) y correlación negativa con calidad de vida SF-36 ($r = -0.58$).
Validez de constructo	Análisis factoriales confirmatorios demuestran un modelo bifactorial o trifactorial (Eficiencia del sueño, Calidad percibida y Perturbación diaria) subordinado al índice global.
Sensibilidad y especificidad	Punto de corte > 5 : sensibilidad del 89.6% y especificidad del 86.5% para discriminar pacientes con patología del sueño clínicamente diagnosticada de sujetos sanos.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÓMPUTO DE PUNTUACIONES

Marco temporal evaluado	Todas las preguntas se refieren exclusivamente al patrón de sueño habitual durante el último mes .
Cálculo de componentes	Se calculan las 7 puntuaciones componentes (C1 a C7), cada una transformada obligatoriamente a una escala estándar de 0 a 3 puntos según el manual formal de codificación.
Eficiencia de sueño (C4)	Fórmula: $\text{Eficiencia} = \left(\frac{\text{Horas dormidas [Ítem 4]}}{\text{Horas en cama [Ítems 1 y 3]}} \right) \times 100\%$. $> 85\% = 0$; $75 - 84\% = 1$; $65 - 74\% = 2$; $< 65\% = 3$.
Puntuación global PSQI	Suma aritmética directa de los 7 componentes: PSQI Total = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6 + C7. Rango teórico: 0 a 21 puntos .
Ítems del compañero de cama	Los ítems respondidos por el acompañante (preguntas complementarias) no suman al total del PSQI; tienen carácter cualitativo para despistaje de roncopatía o SAHOS.

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación Global	Percentil	Clasificación	Significación Clínica y Acción Recomendada
0 - 5	$< \text{Pc } 60$	Buen Durmiente	Sin alteraciones clínicamente relevantes en el sueño habitual.
6 - 10	$\text{Pc } 65 - \text{Pc } 85$	Mal Durmiente Leve-Moderado	Alteración clínicamente significativa; evaluar higiene y causas.
11 - 15	$\text{Pc } 90 - \text{Pc } 97$	Perturbación Grave del Sueño	Típico de trastornos psiquiátricos, dolor crónico o SAHOS.
16 - 21	$> \text{Pc } 98$	Disfunción Severa del Sueño	Patología del sueño extrema; alto riesgo psicofisiológico.

PUNTO DE CORTE CLÍNICO UNIVERSAL:

- **PSQI > 5 :** Define al "mal durmiente" con una sensibilidad del 89.6% y especificidad del 86.5%. Indica la necesidad imperativa de anamnesis detallada y diagnóstico diferencial de trastornos primarios o secundarios del sueño.

DECISIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO, SEGURIDAD Y BIBLIOGRAFÍA

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Cribado inicial con PSQI Total: Si $PSQI \leq 5$, paciente buen durmiente. Si $PSQI > 5$, analizar el perfil de los 7 componentes.

Paso 2: Análisis de Componentes Específicos:

- Si **C2 (Latencia)** y **C4 (Eficiencia)** están alterados (≥ 2), sospecha de insomnio psicofisiológico; pautar TCC-I.
- Si **C5 (Perturbaciones)** es alto: verificar causas físicas (nicturia, dolor articular, dificultad respiratoria nocturna).
- Si **C6 (Uso de medicación)** = 3: evaluar dependencia farmacológica, tolerancia y planificar retirada gradual supervisada.
- Si **C7 (Disfunción diurna)** = 3: explorar depresión mayor subyacente o síndrome de apnea obstructiva del sueño (SAHOS).

Paso 3: Monitorización Posterapéutica: Reevaluar a los 2-3 meses. Una disminución de ≥ 3 puntos en el total PSQI indica beneficio clínico sustancial.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO MULTIDISCIPLINAR

Identificación: Paciente mujer de 52 años, administrativa, remitida a la Unidad de Salud Mental por astenia crónica, problemas de concentración y malestar difuso atribuido inicialmente a síndrome climatérico.

Evaluación Inicial: Puntuación global $PSQI = 15 / 21$ (Perturbación Grave del Sueño). Desglose de componentes: C1 (Calidad) = 3; C2 (Latencia > 60 min) = 3; C3 (Duración < 5 h) = 3; C4 (Eficiencia 58%) = 3; C5 (Perturbaciones nocturnas) = 2; C6 (Sin medicación) = 0; C7 (Disfunción diurna severa) = 1.

Juicio Diagnóstico: Insomnio crónico severo comórbido con Trastorno de Ansiedad Generalizada no diagnosticado previamente.

Plan Terapéutico: Se instauró TCC-I intensiva (restricción del sueño a 6.5 h, deshabitación de pantallas nocturnas) asociada a sertralina 50 mg/día.

Reevaluación a los 3 meses: La puntuación global del PSQI descendió a $4 / 21$ (Buen durmiente), la latencia se redujo a 20 minutos y la eficiencia del sueño aumentó al 89%, con remisión completa de la astenia laboral.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

Banderas Rojas y Riesgos Médicos:

- **Ronquidos Intensos y Pausas Respiratorias:** Si el compañero de cama reporta apneas observadas o sofocos, realizar estudio respiratorio urgente (SAHOS).
- **Somnolencia Extrema al Conducir:** Si C7 se acompaña de microsueños en vigilia, prohibir conducción y evaluar con Escala de Epworth.

Diagnóstico Diferencial:

- **Depresión Mayor con Insomnio Terminal:** El PSQI elevado puede ser la manifestación prodromática de un episodio afectivo mayor.
- **Dolor Crónico / Fibromialgia:** Descartar causas algológicas primarias que impidan el inicio y mantenimiento del sueño.
- **Abuso de Sustancias / Cafeína / Alcohol:** El alcohol induce somnolencia inicial pero fragmenta la segunda mitad de la noche.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS (FORMATO APA 7ª ED.)

- Buysse, D. J., Reynolds, C. F., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28(2), 193-213. [https://doi.org/10.1016/0165-1781\(89\)90047-4](https://doi.org/10.1016/0165-1781(89)90047-4)
- Jiménez-Genchi, A., Monteverde-Maldonado, E., Nenclares-Portocarrero, A., Esquivel-Adame, G., & de la Vega-Pacheco, A. (2008). Confiabilidad y validez de la versión en español del Índice de Calidad de Sueño de Pittsburgh en pacientes psiquiátricos. *Salud Mental*, 31(5), 363-369.
- Royuela, A., & Macías, J. A. (1997). Propiedades clinimétricas de la versión castellana del Cuestionario de Pittsburgh. *Vigilia-Sueño*, 9(2), 81-94.
- Mollaveva, T., Thuraijah, P., Burton, K., Mollaveva, S., Shapiro, C. M., & Colantonio, A. (2016). The Pittsburgh Sleep Quality Index as a screening tool for sleep dysfunction in clinical and non-clinical samples: A systematic review and meta-analysis. *Sleep Medicine Reviews*, 25, 52-73.